

ITEM 275 : ICTERE

Ictère = coloration jaune-bronze généralisée des téguments, due à une augmentation de la bilirubinémie > 40 µmol/L

- **Bilirubinémie totale** : norme < 20 µmol/L → **sub-ictère** = 20 à 40 µmol/L ou **ictère** > 40 µmol/L

- Bilirubine : **non conjuguée** (< 15 µmol/L) ou **conjuguée à l'acide glucuronique** (< 5 µmol/L)

Physiopath	Cycle de la bilirubine	- Macrophage : dégradation de l'hémoglobine des hématies sénescents → production de bilirubine - Bilirubine non conjuguée : peu hydrosoluble, transport par l'albumine jusqu'au foie (sans passer la barrière glomérulaire : aucun passage dans l'urine) - Conjugaison à l'ac. glucuronique dans les hépatocytes par la bilirubine-UDP-glucuronosyl-transférase 1 - Excrétion de la bilirubine conjuguée au pôle biliaire des hépatocytes par transport actif, saturable, sélectif et compétitif (± reflux possible dans le plasma : bilirubine non conjuguée hydrosoluble → urines) → Le flux biliaire est généré osmotiquement par les acides biliaires : une diminution des acides biliaires entraîne une diminution de l'excrétion de bilirubine			
	Anomalie	- Cholestase ictérique : ↘ de sécrétion des acides biliaires et de bilirubine conjuguée → reflux plasmatique - Cholestase anictérique : ↘ de sécrétion des acides biliaires avec bilirubine conjuguée normale - ↗ Bilirubine non conjuguée : ↗ destruction de l'Hb ou ↘ captation/conjugaison par l'hépatocyte - ↗ Bilirubine conjuguée : ↘ excrétion de la bilirubine conjuguée dans la bile par l'hépatocyte			
ICTÈRE A BILIRUBINE LIBRE	- Hyperhémolyse : ictère hémolytique, accompagné ou non d'une anémie (↗ réticulocyte) - Dysérythropoïèse : destruction intra-médullaire des hématies (réticulocytes non augmentés) - Baisse de la conjugaison : ictère du nouveau-né (transitoire), syndrome de Gilbert ou syndrome de Crigler-Najjar				
	Syndrome de Gilbert	= Polymorphisme non pathologique du gène promoteur de la bilirubine-glucuronyl-transférase : transmission autosomique récessive, bénin, fréquent (3 à 10% de la population) - Hyperbilirubinémie libre modérée (< 80 µmol/L) et fluctuante - Ictère inconstant et variable : ↗ par le jeûn ou une infection, ↘ par inducteur enzymatique → Diagnostic d'élimination : signes compatibles, sans anomalie hépatique			
	Syndrome de Crigler-Najar	= Absence/effondrement de l'activité de la glucuronyl-transférase : autosomique récessif, rare, grave - Ictère néonatal marqué, permanent, avec bilirubinémie libre > 100 µmol/L - Potentiellement grave : risque d'encéphalopathie bilirubinique			
ICTÈRE A BILIRUBINE CONJUGUÉE	Cholestase	SF	- Prurit : par reflux des acides biliaires - Amaigrissement non spécifique en cas de cholestase chronique (malabsorption) - Douleur en cas de mise en tension brutale des voies biliaires		
			Bio	= Diminution de la sécrétion biliaire : ↗ PAL et GGT	
		Echo	- Dilatation des voies biliaires : dilatation harmonieuse du territoire en amont de l'obstacle → Possiblement absente si : obstruction récente, paroi scléreuse ou cirrhose - Absence de dilatation : atteinte des canaux biliaires de petit ou moyen calibre - Dilatation de la vésicule biliaire : évocatrice d'un obstacle cholédocien (aval de la convergence des canaux cystique et hépatique commun) sur vésicule saine → obstacle néoplasique ++		
		Cholestase extra-hépatique	→ Une atteinte limitée de la voie biliaire principale peut entraîner un ictère, mais une atteinte des canaux de plus petit calibre doit être diffuse pour provoquer un ictère		
			Voie biliaire principale	- Lithiase de la voie principale : douleur biliaire ± fièvre si angiocholite - Cancer de la tête du pancréas : ictère ± douleur épigastrique, AEG profonde - Cancer de la voie biliaire principale : ictère nu, sans fièvre ni douleur - Ampullome vatérien : anémie ferriprive, ictère fluctuant - Autre : sténose post-opératoire, compression (ADP, pancréatite chronique)	
			Canaux biliaires de petit ou moyen calibre	- Cirrhose biliaire primitive = affection auto-immune rare : cholangite destructrice non suppurée des canaux biliaires microscopiques, Ac anti-M2 → ictère tardif - Cholangite immuno-allergique médicamenteuse (pénicilline, sulfamide, macrolide, allopurinol...) : fièvre, douleur de l'HCD, hyperéosinophilie - Cholangite sclérosante primitive = irrégularités (sténoses et dilatations) des canaux biliaires intra- et extra-hépatiques : associée dans > 50% des cas à une MICI, facteur favorisant de cholangiocarcinome - Cause génétique : mucoviscidose, mutation du gène MDR3	
			Métastase hépatique	- Ictère tardif par : - Compression/envahissement de la VBP (majorité) - Infiltration hépatique : cholestase généralement anictérique	

ICTERE A BC	Cholestase	Cholestase intra-hépatique	Acquise : inhibition du transport par des cytokines inflammatoires - Hépatite aiguë : ictère intense sans ↗ PAL et GGT - Infection bactérienne sévère: pyélonéphrite, pneumonie, typhoïde, leptospirose... Génétique (très rare) : - Cholestase intra-hépatique familiale progressive : infantile - Cholestase récurrente bénigne : récidivant, régressive	
	Atteinte du transport canaliculaire de la bilirubine		= 2 affections génétiques rarissimes et bénignes : - Syndrome de Rotor - Maladie de Dubin-Johnson	
Mixte	= Malade en état grave, infecté, cirrhotique ou en soins intensifs : - Mécanismes : - ↘ de la sécrétion canaliculaire de la bilirubine conjuguée : syndrome inflammatoire - Hyperhémolyse : transfusion, dispositifs intra-vasculaires - Insuffisance hépatique, ictère aggravé par une insuffisance rénale			
Situations d'urgence	Ictère nucléaire	= Toxicité de la bilirubine non conjuguée sur le cerveau → séquelles cognitivo-motrices graves - Cause : hyperhémolyse (incompatibilité materno-foetale...), syndrome de Crigler-Najjar - TTT : photothérapie (UV) ou échange plasmatique		
	Angiocholite	= Infection bactérienne de la bile et des voies biliaires, presque toujours liée à une lithiasie - Cholestase, syndrome inflammatoire systémique, mise en évidence d'une obstruction biliaire - DD = SRIS sévère sans obstruction biliaire : infection bactérienne sévère (PNA, pneumonie, péritonite...), lymphome, phase initiale d'une hépatite A ou d'une hépatite herpétique		
	Insuffisance hépatique	Cirrhose	→ Une poussée d'ictère doit faire rechercher : - Poussée de la maladie causale : exacerbation d'hépatite virale, alcoolique... - Complication ou phénomène intercurrent : cancer, infection bactérienne, IRA, prise de médicament hépatotoxique, hémorragie, hyperhémolyse	
		Cancer du foie terminal	- Compression de la voie biliaire par une MT ou la tumeur primitive - Stade très avancé avec localisations multifocales et insuffisance hépatique	
		Insuffisance hépatique aiguë	= Toxique (paracétamol, amanite phalloïde), médicamenteuse immuno-allergique, virale , ou association d'une des causes avec la prise de paracétamol - Hépatite grave si TP < 50% → risque d'évolution vers l'hépatite fulminante	
Démarche diagnostique	C	- DD = coloration jaune (rare) : alimentation riche en légumes rouges-oranges, médicament (fluorésceïne) - Ictère nu : sans fièvre ni douleur associée - Ictère à bilirubine conjuguée : coloration brune des urines et selles décolorées → Ictère à bilirubine libre : possible coloration foncée des urines en cas d'hémoglobinurie par hyperhémolyse - Ictère cholestatique : prurit associé (par reflux des acides biliaires) - Ictère par obstruction cholédocienne non lithiasique : dilatation de la vésicule (palpable)		
	Bio	- Bilirubinémie : dosage de la bilirubine non conjuguée (N < 15), conjuguée (N < 5) et totale (N < 20) - Ictère hémolytique : ↗ bilirubine libre, ↗ réticulocytes, ↘ haptoglobine - Ictère cholestatique : ↗ PAL, ↗ GGT ± ↗ modérée des transaminases - Ictère cytolytique : à évoquer en cas de forte élévation des transaminases > 10 à 20N		
	PC	Echographie abdominale	Lithiasie biliaire : formation hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur - DD : aérobie (antécédent de sphinctérotomie ou d'anastomose bilio-digestive) Obstruction de la voie biliaire principale ou de la convergence des canaux hépatiques droit et gauche : dilatation diffuse et harmonieuse des voies biliaires intra-hépatiques - Siège de l'obstacle : - Canal hépatique commun : cholédoque non dilaté, vésicule normale - Canal cholédoque : vésicule et canal hépatique commun dilatés	
		TDM	- Lithiasie biliaire ou obstruction de la voie biliaire principale, analyse fine du pancréas	
		Bili-IRM	= Coûteux, peu disponible : visualisation de bonne qualité des voies biliaires et pancréatiques - Visualisation de cholangite sclérosante primitive et de cancer primitif des voies biliaires	
		Echo-endoscopie	= Coûteux, invasif, nécessite une AG : - Le plus performant pour le diagnostic de lithiasie de la voie biliaire principale et de la vésicule - Permet des biopsies dirigées du pancréas ou d'ADP	
		CPRE	= Coûteux, très invasif, risque d'angiocholite et de pancréatite : uniquement à but thérapeutique - Biopsie des obstacles des canaux biliaires - Thérapeutique : extraction de calcul, lithotritie, sphinctérotomie, prothèse de sténose	
	Cholangiographie percutanée trans-hépatique	= Coûteux, très invasif, sous AG, EI (hémopéritoine, biliopéritoine, angiocholite) - En cas d'échec de CPRE : drainage, biopsie, extraction de calcul, lithotritie		

CANCER DES VOIES BILIAIRES

Type	Carcinome de la vésicule biliaire	- FdR : - Lithiasse biliaire : cholécystite chronique - Anomalie de la jonction bilio-pancréatique - Cholangite sclérosante primitive - Asymptomatique (50%) : découverte fortuite sur pièce de cholécystectomie → ré-intervention carcinologique (cholécystectomie complète, hépatectomie partielle, curage) après bilan d'extension - Symptomatique (tardif) : douleur abdominale, ictère, masse abdominale palpable, AEG - Complication : ADP, MT hépatique, envahissement de l'artère ou du pédicule hépatique
	Ampullome vatérien	= Adénocarcinome siégeant sur l'ampoule de Vater : d'origine biliaire, pancréatique ou duodénal - Manifestations : - Ictère cholestatique fluctuant avec dilatation de la voie biliaire principale - Pancréatite aiguë - Angiocholite - Hémorragie digestive peu abondante : anémie ferriprive, méléna - Duodénoscopie : visualisation de la tumeur et biopsies - TTT radical : duodéno-pancréatectomie céphalique - TTT palliatif : drainage biliaire par prothèse endoscopique ou anastomose bilio-digestive
	Cholangio-carcinome	= Intra-hépatique ou extra-hépatique (proximal ou distal) : évolution rapide, de mauvaise pronostic - FdR : - Parasitose : distomatose - Cholangite sclérosante primitive (± associée à une MICI) - Cirrhose - Syndrome de Lynch - Manifestations : - Intra-hépatique : douleurs abdominales en hypochondre droit, sans ictère - Extra-hépatique : ictère cholestatique - Diagnostic : CPRE ou bili-IRM